

Referencia	GRUPO Modulo Cobertura Funcional
	GRUPO MODULOS CONFIGURACION, PARAMETRIZACION, ADAPTACION
1.0	Configuración de Datos Maestros Generales
	El repositorio de datos maestros central deberá contener la configuración de las distintas entidades que definen y caracterizan la estructura hospitalaria, tales como departamentos, servicios, etc
	El repositorio de datos maestros central deberá contener la configuración de las distintas entidades que definen y caracterizan la estructura de recursos humanos, equipos médicos, grupos y perfiles de usuarios, permisos, etc.
	El repositorio de datos maestros central deberá contener la configuración de las distintas categorías que definen y caracterizan la estructura de los distintos episodios clínicos, tales como agendas, actividades, etc.
	El repositorio de datos maestros central deberá contener los listados estándar de codificación de elementos médicos, tales como diagnósticos, procedimientos, etc.
	El repositorio de datos maestros central deberá contener las plantillas estándar de los diferentes tipos de informes médicos y administrativos que se pueden registrar en el sistema.
	El repositorio de datos maestros central deberá contener la configuración que definen y caracterizan la estructura del material médico o fungible, incluyendo elementos como familias de artículos y medicamentos, listado de principios activos, listado de medicamentos, etc.
	El repositorio de datos maestros central deberá contener la definición y caracterización de los proveedores de abastecimiento.
2.0	Configuración de Maestros Locales "Cuando en el proyecto los centros hospitalarios dependan de un ente superior que comande los Maestros generales"
	Dentro de este repositorio central de datos de configuración, cada centro podrá decidir qué elementos desea importar para que formen parte de su configuración propia y personalizada.
	Cada uno de los centros asociados podrá definir nuevos elementos de configuración propios que no serán compartidos por el resto de centros, es decir, sin que su configuración personalizada interfiera con la del resto de centros.
3.0	Usuarios/ Perfiles / Seguridad
	El sistema debe de permitir la creación, modificación, y baja de usuarios y la asignación de privilegios de acceso a los diferentes módulos de la aplicación.
	El acceso a la aplicación se realizará mediante la autenticación del usuario por medio de un nombre de usuario y una contraseña
	El sistema deberá ofrecer la posibilidad de iniciar sesión con medios alternativos, como lectores biométricos y certificados digitales.
	El inicio de sesión de un usuario autenticado en el sistema caducará pasado cierto tiempo de inactividad. El tiempo de inactividad que provoca la caducidad de la sesión deberá ser configurable.
	El sistema debe de suministrar métodos para evitar que el inicio de sesión se pueda realizar de forma fraudulenta mediante el uso de "robots" otro tipo de sistemas automatizados malintencionados; como el Control de acceso por Captcha.
	El sistema deber suministrar algún método automático para asegurar que el usuario selecciona una contraseña lo suficientemente compleja para que no pueda ser adivinada por personas o sistemas malintencionados
	El sistema obligará a que el usuario cambie su contraseña de forma periódica. El tiempo de expiración de una contraseña deberá ser configurable o podrá ser desactivado a demanda del cliente.
	El sistema deberá permitir la creación de grupos de usuarios o perfiles, de manera que el control de acceso de cada usuario a los diferentes módulos de la aplicación no tenga que ser gestionado para cada usuario individual.
	Posibilita un ajuste más detallado de los permisos de cada usuario o grupos de usuarios en las operaciones propias de cada uno de los módulos.
	El sistema deberá permitir la activación de un registro de los accesos y modificaciones por parte de cada usuario en los elementos más críticos de la aplicación. El sistema deberá suministrar una interfaz sencilla y clara para que los usuarios con permisos suficientes puedan consultar este registro de actividad
4.0	MPI-Master Patient Index (MPI) e Historial Médico Centralizado
	Cada vez que un paciente es creado en uno de los centros asociados, el sistema deberá realizar una búsqueda a partir de varios criterios en el sistema MPI y, en el caso de que exista, importar sus datos demográficos para que sean incluidos a nivel local.
	Cuando se modifican los datos de un paciente, estas modificaciones deberán de ser enviadas al resto de centros asociados para que los cambios puedan ser actualizados a nivel local.
	Esta sincronización de cambios en los datos de paciente deberá funcionar de manera asíncrona. Cada uno de los centros asociados podrá planificar de manera autónoma el momento en el que estos cambios serán sincronizados.
	En el caso de que, por el motivo que fuere, un centro se encuentre fuera de línea, el conjunto de cambios a sincronizar
	El sistema deberá suministrar un tablero de mandos, sencillo e intuitivo, desde el cual los usuarios podrán consultar los elementos que forman parte del historial clínico y administrativo del paciente y que han sido registrados en otros centros asociados.
	La visualización de los datos de paciente que forman parte de esta historia clínica centralizada deberá seguir una ordenación basada en línea temporal.
	Los elementos a mostrar en el tablero de visualización de datos clínicos centralizados deberán ser configurable por centro, grupo o usuario.
	El tablero de visualización de datos clínicos centralizados mostrará un diagrama de las relaciones entre todos los episodios del paciente y eventos relacionados, presentado de manera visual y organizada.
5.0	Historia Clínica Electronica
	El sistema deberá asignar un identificador único a cada paciente registrado en el sistema. Este identificador único deberá de mantenerse invariable durante todo el ciclo de vida de la aplicación y deberá permitir asociar al paciente con cada uno de los elementos que puedan formar parte de su historia clínica.
	Se debe disponer de un sistema de búsqueda de historias clínicas a partir de diferentes criterios como el nombre del paciente o el número de documento de identidad.
	El sistema deberá comprobar, en el momento de registro de un nuevo paciente, si ya existen pacientes que compartan datos con un alto grado de coincidencia. En el caso de que así sea, el sistema deberá informar al usuario, ofreciéndole la opción de cancelar la operación y seleccionar al paciente ya existente.
	Para aquellos pacientes que, por error, han sido registrados más de una vez en el sistema con distinto identificador, la aplicación debe permitir fusionar los datos de ambas historias clínicas en una sola. Esta operación deberá trasladar los registros clínicos y administrativos asociados de una historia clínica a otra y dar de baja automáticamente una de ellas.
	El sistema deberá disponer de una vista en la que se relacionen todas los episodios y visitas del paciente ordenados de forma cronológica.
	El sistema deberá poner a disposición del equipo médico un listado agrupado y organizado de forma cronológica de los diferentes informes, pruebas diagnósticas, intervenciones quirúrgicas y demás documentación asociada a la historia clínica de un paciente.
	Deberá existir la posibilidad de asociar informes de diferente tipo con una historia clínica. Estos informes podrán estar relacionados con la atención primaria, interconsultas de atención especializada, episodios de hospitalización y urgencias o informes de resultado de pruebas diagnósticas.
	Debe existir la posibilidad de asociar avisos a determinados pacientes. El sistema mostrará una ventana con el aviso correspondiente cuando los usuarios accedan a la historia clínica del paciente.
	El sistema permitirá la impresión de elementos identificativos del paciente, tales como etiquetas o pulseras.
	Se debe permitir asociar documentos a la historia clínica del paciente, tales como informes o resultados de pruebas efectuadas en otros centros sanitarios
6.0	Portal WEB
	Posibilidad de crear un portal Web a nivel nacional, para que tanto el personal sanitario como los pacientes puedan consultar y gestionar información relevante.
7.0	BI (En la pestaña BI-Cuadro Informes más información)
	Área de ingresos
	Número total de ingresos comprendidos dentro de un periodo temporal, por servicios, por consultas, por tipo de diagnóstico, por precedencia, por aseguradora, por sexo y rango de edad del paciente, etc.
	Tiempos de espera en los ingresos
	Número de ingresos procedentes de urgencias
	Traslados de pacientes
	Tasa de mortalidad

	Tasa de ocupación, estancias y rotación
	Área de urgencias
	Número total de urgencias por periodo temporal clasificado por tipo de urgencia, por servicio, por diagnóstico, por turno laboral, por aseguradora, por sexo y rango de edad del paciente, número de actividades realizadas en episodios de urgencias
	Área de consultas
	Número total de citas por periodo temporal clasificadas por procedencia, por aseguradora, por tipo de episodio, por sexo y rango de edad del paciente, etc.
	Tiempos de lista de espera de consultas.
	Diferencia temporal entre solicitud y asignación de citas
	Área de quirófano
	Número de intervenciones programadas y urgentes, por tipo de intervención, por procedimiento quirúrgico, por tipo de anestesia, por servicio, por diagnóstico.
	Número de intervenciones canceladas
	Indicadores de uso y rendimiento de la sala de operaciones
	Área de obstetricia
	Número total de partos por período de tiempo, clasificados por sexo, tipo, etc.
	Tasa de mortalidad materna o fetal
	Área de laboratorio clínico
	Número de pruebas de laboratorio realizadas por un periodo determinado y clasificadas por tipo de muestra, grupos de pruebas, aseguradoras, médico, servicio, sexo del paciente, etc.
	Número de gérmenes detectados y perfiles de antibióticos. Plazos para la realización de exámenes
	Prescripción médica
	Prescripción y dispensación de medicamentos por periodo temporal y clasificados por tipo de episodio, servicio, médico, familia y grupo del medicamento
	Número total de recetas confirmadas.
	Área de suministro
	Compras por periodo temporal y clasificado por tipo de compra, centro de coste, proveedores
	Consumos de material por periodo temporal y clasificado por centro de coste, grupos de artículos, aseguradoras
	Área de facturación y cobros
	Monto facturado durante un período de tiempo, clasificado por compañía de seguros y tipo de póliza, centro de costos, departamento, tipo de episodio del paciente, conceptos de facturación, etc.
	Monto cobrado por periodo de tiempo y clasificado por servicio, tipo de episodio, compañía de seguros, forma de pago, etc.
	Proceso de extracción y procesamiento de datos diferido para no interferir con la actividad diaria
	Estructura multidimensional que permite diferentes combinaciones de filtrado
	Métricas de actividad calculadas de antemano
	Reportes personalizables por áreas y servicios
	Permisos de acceso a datos basados en perfiles de usuario
	Posibilidad de explotación de datos personalizada mediante herramientas de "autoservicio"
	GRUPO MODULOS ADMINISTRATIVOS
1.0	Gestión de pacientes
	Identificación y registro del paciente: Al registrar al paciente en el sistema, se asigna un número único de historia clínica (PPI). Este código es la identificación del paciente para todo el sistema y todos los episodios y documentos creados se agrupan en la historia clínica electrónica del paciente.
	Historial medico-administrativo de pacientes: Visualización de registros administrativos: episodios del paciente, colocación en lista de espera, procedimientos quirúrgicos, admisiones, etc., permitiendo buscar datos específicos de un expediente médico mediante filtros personalizados por el usuario.
	Fusión de historias clínicas: permite fusionar datos de dos historias clínicas del mismo paciente para evitar errores de duplicidad de información.
	Gestión de avisos administrativos: Generación de avisos personalizados por paciente y dirigidos al personal administrativo.
	Exportación de la historia clínica del paciente en formato PDF para la entrega al paciente o a terceros.
	Impresión de pulseras identificativas para pacientes.
	Incorporación de documentos al expediente médico del paciente: resultados de exámenes realizados en otros centros de salud, etc.
2.0	Urgencias
	El sistema deberá registrar la hora de entrada del paciente en el servicio de urgencias, junto con otros datos como el lugar de entrada, la procedencia, el box ocupado por el paciente, observaciones, la clasificación inicial de la urgencia, etc.
	El sistema, al inicio del episodio de urgencias, permitirá la impresión de una pulsera identificativa con los datos del paciente y del episodio
	La aplicación deberá disponer de un sistema de triage mediante el cual sea posible clasificar las diferentes urgencias en proceso en función de su gravedad. Este sistema permitirá, tras una observación inicial, especificar la prioridad de atención de los pacientes en función de su gravedad.
	El sistema deberá registrar las diferentes atenciones que recibe el paciente durante el proceso de urgencias, así como diferentes profesionales que llevan a cabo cada atención.
	El sistema deberá registrar y gestionar las diferentes solicitudes de pruebas diagnósticas asociando los resultados al episodio e incluyéndolos de forma automática en el historial clínico del paciente.
	El sistema permitirá la realización de consultas a especialistas manejando todo el flujo de preguntas y respuestas de manera automática.
	Se deberá poder asociar a un episodio de urgencias la lista de pertenencias del paciente, en el caso de que este no sea autónomo o acuda en estado de inconsciencia.
	En los casos en los que, debido al estado del paciente, sea imposible identificar a éste, el sistema permitirá la creación de un número identificador temporal. Posteriormente, los datos asociados a este número identificador temporal podrán ser trasladados a la historia clínica del paciente una vez que éste haya sido identificado correctamente.
	Se podrán imprimir, a partir de los datos del episodio, diferentes documentos justificativos como asistencia al servicio de urgencias, partes judiciales, etc
	El sistema generará de forma automática, a partir de los datos del episodio, el informe de alta en el momento en el que se cierra el episodio.
	El sistema permitirá, en el caso de que fuera necesario, el traslado directo del paciente al servicio de hospitalización registrando, de manera automática, los datos ya conocidos en el nuevo episodio de hospitalización.
	El sistema deberá asociar, de manera automática, todos los datos generados durante el episodio al expediente de historia clínica electrónica del paciente
	El sistema permitirá la facturación inmediata cuando finaliza la hospitalización del paciente, incluidos todos los conceptos facturables. Este proceso se realizará de forma automática a través de la configuración de los distintos conceptos asociados a la atención asistencial: análisis, exploraciones diagnósticas, fármacos, etc.
3.0	Sistema de Citas y Agendas
	El sistema debe permitir definir agendas de consulta médica de diferentes tipos, asociando cada una de ellas con un servicio, un médico y una sala concreta.
	El sistema deberá permitir definir los periodos hábiles de cada agenda indicando los días de la semana y el horario disponible.
	La programación de citas deberá permitir definir una duración estimada para cada una de las actividades asociadas a la agenda. En el momento de asignar una nueva cita a un paciente, la duración de la actividad a realizar deberá de ser tenida en cuenta de manera que se evite la saturación de una agenda por exceso de citas.
	La programación de citas deberá de tener en cuenta las distintas festividades del territorio en el que se desarrolla la actividad.
	El sistema deberá permitir, en una sola operación, asignar varias citas a un mismo paciente variando para cada una la actividad a realizar o indicando la periodicidad de cada cita.
	El sistema deberá permitir excepciones al control de ocupación de una agenda, de manera que se puedan concertar citas de urgencia en el caso de que sea necesario.
	Cada cita deberá contar con diferentes estados que indiquen en qué situación se encuentra la cita. El sistema permitirá registrar un motivo de cancelación en el caso de cancelar una cita.
	Cada una de las actividades disponibles podrán tener asociada una plantilla de preparación imprimible para que el usuario pueda entregar al paciente las instrucciones a seguir antes de la cita.
	El sistema permitirá la generación de listados de trabajo a disposición del facultativo o sus asistentes donde se detalle la programación diaria de cada agenda.
	El sistema dispondrá de un sistema de avisos y recordatorios mediante el cual se recordará al paciente, de forma telemática, la fecha de sus citas. Este servicio podrá ser prestado mediante correo electrónico o, en caso de que el centro hospitalario disponga del servicio, mediante envío de mensajes SMS.

	La aplicación dispondrá de un sistema de listas de espera en la que se pueda incluir a los pacientes que, por el motivo que fuere, tienen pendiente la asignación de fecha para una cita. Una vez que la agenda está disponible para concertar la cita, el paciente deberá ser eliminado automáticamente de esta lista de espera
	La aplicación permitirá imprimir automáticamente un justificante de la cita que podrá ser entregado al paciente
	El sistema debe de permitir el bloqueo temporal de una agenda durante un periodo concreto. En este caso, el sistema debe de asistir al usuario automatizando de algún modo el proceso de reprogramación de las citas afectadas por el bloqueo y de generación automática del listado de citas reprogramadas para que el personal pueda gestionar la notificación de la reprogramación al paciente
	El sistema permitirá la facturación automática al finalizar la consulta, incluyendo todos los conceptos facturables por línea o por paquete.
	El sistema permitirá la realización de informes de consulta con modelos predefinidos previamente configurados y de fácil acceso para el facultativo.
	La aplicación deberá disponer de una serie de listados, generados en varios formatos o imprimibles en papel, con información estadística sobre:
	* Citas solicitadas, citas pendientes, citas completadas y citas canceladas por médico, por departamento, etc.
	* Indicadores estadísticos sobre actividad y calidad, tales como, porcentaje de cancelaciones, retrasos medios, etc.
	* Otros.
4.0	Lista de espera
	El sistema permitirá administrar y controlar las solicitudes de inclusión o salida de la Lista de espera. Los diferentes tipos de Listas de Espera que se gestionan son: *Hospitalización *Consultas ambulatorias *Exámenes de diagnóstico *Procedimientos quirúrgicos con hospitalización *Procedimientos de cirugía mayor ambulatoria *Procedimientos de cirugía menor ambulatoria
	Gestionar la lista de espera según el tipo de lista, prioridad, tiempos de espera, motivo de inclusión o motivo de salida. Crear procesos automáticos que registren la salida de una Lista de Espera cuando se realizan determinados procesos en los diferentes módulos del sistema.
	Gestión centralizada de listas de espera. Integración de lista de espera con todos los módulos a los que debe aportar información (citas, quirófanos y preingresos) generando procesos automatizados que permitan reducir tiempos de respuesta y la optimización de recursos y una mejor atención al paciente.
	Posibilidad de definir los diferentes tipos de lista de espera, los diferentes tipos de prioridades, los posibles motivos de inclusión y salida.
	Mantenimiento de la lista de espera quirúrgica según prioridades y tiempos de espera con la finalidad de permitir la adaptación de la oferta a la demanda de servicios de los pacientes.
	Historico de pacientes que están o han estado en lista de espera en algún momento, aportando motivo de inclusión en lista de espera y salida, si aplica.
	Obtener estadísticas sobre la evolución y estado de la lista de espera
5.0	Hospitalización
	El sistema permitirá el registro de una prehospitización, mediante la cual se podrá establecer una reserva de la cama a ocupar por el paciente, así como la preparación del equipamiento necesario para cubrir el episodio de hospitalización.
	El sistema permitirá registrar los datos de inicio del episodio de hospitalización, trasladando automáticamente, si fuera el caso, los datos de la prehospitización y permitiendo el registro de información adicional asociada al episodio. Entre la información a registrar se encuentra el médico responsable de la hospitalización, el lugar de la hospitalización y el servicio asociado, el motivo y origen del ingreso, el diagnóstico inicial motivo del ingreso y la duración prevista para la estancia, entre otros.
	El sistema, al inicio del episodio de urgencias, permitirá la impresión de una pulsera identificativa con los datos del paciente y del episodio
	El sistema permitirá la gestión eficiente de las camas del servicio de hospitalización, permitiendo conocer en cada momento la disponibilidad de las mismas dentro de cada servicio y ubicación y la posibilidad de establecer bloqueos o reservas.
	El sistema también permitirá la reserva de cama, si procede, para el acompañante del paciente.
	El sistema permitirá la realización de traslados del paciente a otras camas, a otros servicios, así como el cambio de médico responsable del episodio de hospitalización.
	El sistema deberá registrar y gestionar las diferentes solicitudes de pruebas diagnósticas asociando los resultados al episodio e incluyéndolos de forma automática en el historial clínico del paciente.
	El sistema permitirá la realización de consultas a especialistas manejando todo el flujo de preguntas y respuestas de manera automática.
	Se podrán imprimir, a partir de los datos del episodio, diferentes documentos justificativos como presencia del paciente en situación de hospitalización, partes de acompañante, etc.
	El sistema deberá asociar, de manera automática, todos los datos generados durante el episodio al expediente de historia clínica electrónica del paciente
	El sistema generará de forma automática, a partir de los datos del episodio, el informe de alta en el momento en el que se cierra el episodio
	El sistema permitirá la facturación inmediata cuando el paciente recibe la autorización de alta, incluyéndose de manera automática todos los conceptos facturables de los que se benefició el paciente durante su hospitalización. Proceso automatizado donde se configuran los distintos conceptos facturables asociados a la cuenta del paciente: por ejemplo estancias, análisis de laboratorio, equipo utilizado, medicamentos dispensados, exámenes diagnósticos realizados, etc.
	La aplicación deberá disponer de una serie de listados, generados en varios formatos o imprimibles en papel, con información estadística sobre:
	*Datos de hospitalizaciones, altas y traslados por médico, por departamento
	*Gestión del alojamiento, los traslados y el nivel de ocupación
	*Estancia media total y por departamento.
	*Otros
6.0	Teleconsulta
	El módulo de citación deberá incluir la posibilidad de programar ciertas consultas para que sean realizadas en la modalidad de videoconferencia.
	El sistema deberá enviar a los pacientes citados en la modalidad de videoconferencia un aviso, bien mediante correo electrónico, bien mediante mensajes SMS con los datos de la cita y la fecha de realización. El mensaje deberá incluir un vínculo URL para que el paciente pueda acceder fácilmente a la sala de espera de la videoconsulta. La contratación del servicio de envío de mensajes SMS está fuera del presente contrato.
	El sistema deberá mostrar, dentro de la lista de trabajo del médico, un indicador identificando aquellas citas que se realizarán en modalidad de teleconsulta.
	El sistema deberá mostrar, dentro de la lista de trabajo del médico, un indicador de que el paciente se encuentra en la sala de espera virtual listo para iniciar la videoconsulta.
	El médico deberá de ser capaz de iniciar la videollamada directamente desde la lista de trabajo.
	El sistema deberá permitir el acceso de terceras personas a la teleconsulta. Estas terceras personas pueden ser, bien parte del equipo médico, o bien familiares o personas encargadas de la asistencia al paciente. El acceso de estas terceras personas a la videoconferencia deberá realizarse mediante el envío de un vínculo URL para que el asistente pueda acceder fácilmente a la sala de espera asociada a la videoconsulta que se está llevando a cabo.
	El sistema deberá asegurar la posibilidad de realizar hasta XXX videoconsultas simultaneas.
	Deberá asegurarse una calidad de video y audio, por defecto, de 720p o superior. Esta calidad podrá ser ajustada automáticamente en función del ancho de banda disponible en función de la conexión del paciente.
	La aplicación cliente a utilizar por el paciente para llevar a cabo la teleconsulta deberá ser multiplataforma, pudiéndose trasladar de un dispositivo móvil a un ordenador a través del mismo enlace.
	La aplicación utilizada por el paciente para realizar la videoconferencia deberá incluir la posibilidad de comunicación mediante "chat", así como el envío de documentos digitales
7.0	Facturación
	Capturar los movimientos facturables de forma automática obteniendo la información necesaria de cada módulo de la aplicación para poder realizar la facturación. Por tanto debe recoger toda la actividad hospitalaria que pudiera facturarse de los procesos realizados a cada uno de los pacientes.
	Emitir la factura: Desde la cuenta del paciente, verificar todos los conceptos incluidos, pudiendo editar el listado de trabajos y agruparlos por origen de la actividad: ambulatorio, hospitalización, urgencias, exámenes, etc.
	Gestión de la facturación y sus reglas de gestión configurables. Aplicar reglas de facturación en función del paciente soportando el copago, es decir, la emisión de una factura por parte de los servicios a cargo de la compañía de seguros (facturación a tanto alzado de acuerdo a los Precios de Referencia) y facturación dividida para los pagadores directos.
	Facturación automática de las estancias hospitalarias con diferentes importes en función del número de días y del tipo de actividad en el que se encuentre el paciente.

	Facturación a más de un seguro por el mismo paciente
	Gestión cuentas de facturación del paciente: Facturar todos los servicios de los que el paciente se ha beneficiado en el hospital; agrupando todos los actos, fármacos y materiales facturables generados en los diferentes módulos y asociados al paciente para que cuando se solicite el alta al paciente pueda emitirse automáticamente la factura.
	Gestión de Compañías de Seguros: Ranking de compañías de seguros.
	Posibilidad de cambiar de seguro.
	Gestión de tarifas: Incluir todas las tarifas por compañía de seguros. Asociar las tarifas a una fecha de vigencia permite facturar en cualquier momento con la tarifa correspondiente, permitiendo tener el historial de tarifas por aseguradora.
	Paquetes: Crear "paquetes" por empresa, indicando los conceptos que cubre la empresa para cada paquete. Un paquete involucra agrupaciones de actos, materiales y medicamentos; estos conceptos se facturan juntos, como un solo artículo con sus propios precios, tiempos y cantidades.
	Se podrán crear "n" facturas; una de ellos para la aseguradora correspondiente y el resto de las facturas de los conceptos no cubiertos serán facturados al paciente. Se permitirá la emisión de facturas duplicadas. Saber lo que se ha facturado y lo que está pendiente en todo momento facilita la rentabilidad en el hospital.
	Estadísticas y Listados: Permite obtener datos sobre facturas emitidas o pendientes por paciente, por departamento. Además, proporcionar estadísticas e indicadores de actividad y calidad que facilitan el seguimiento y la toma de decisiones.
8.0	Cajas
	Creación de las diferentes cajas registradoras y configuración de autorizaciones de usuarios. Descentralización de la ubicación de cajas registradoras en una sola ubicación.
	Recuento diario de caja, emitiendo el informe correspondiente al total cobrado por tipo de cobro y usuario
	Editar el estado consolidado de los ingresos totales de caja del día
	Permitir una gestión multicaja
9.0	Gestión de recobros
	Registrar las recuperaciones totales o parciales asociadas a las facturas. La aplicación debe mostrar los pagos ya realizados y calcular automáticamente la cantidad pendiente de pago.
	Tener en cuenta el importe de la fianza durante el pago y calcular el importe restante a pagar.
	Asociación de cobros de importes totales o parciales con las facturas correspondientes.
	Permitir el registro de cheques de garantía y reembolsos de cheques.
	Recaudación y emisión automática de recibos donde se reflejen los siguientes elementos: Fecha del pago, número del recibo, identidad del paciente, número de la factura de la liquidación, cantidad pagada y forma de pago.
	Crear comprobantes para enviar a las compañías de seguros. En estos envíos se indican las facturas a cobrar de la misma compañía de seguros.
	Permitir el reembolso total o parcial o la cancelación de un cobro y rastrear la operación en el sistema
10.0	Suministros
	Permitir una gestión multinivel de las existencias : *Almacenes principales y periféricos *Salas de almacenamiento y distribución *Puntos de consumo (armarios de servicio, PYXIS)
	Establecer distribución por familias, clases y categorías de productos
	Proveedores: Catálogo de proveedores con los que trabajar asociando los materiales, los tipos de compra y las referencias.
	Gestionar los pedidos a proveedores externos. Permitiendo dar respuesta a preguntas universales relacionadas con las compras: ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? 'O' ¿Qué? ¿A quién? Comprar
	Gestionar las devoluciones del circuito de la medicación
	Órdenes: Gestionar las órdenes de compra del hospital, incluyendo procesos automatizados como la creación de órdenes de forma automática en cuanto se alcanza el umbral de la orden o según el nivel de consumo alcanzado. También permite establecer distintos niveles de autorización por usuario para establecer pedidos y pedidos de compra, pudiendo delimitar tanto la autoridad para aprobar como el límite del importe.
	Editar las órdenes de reaprovisionamiento para los diferentes almacenes y centros de distribución
	Gestionar las entradas/salidas de stock manualmente en caso de fallo (en caso de procedimiento degradado, regularización manual), con trazabilidad y motivo según privilegios definidos
	Gestionar las entradas/salidas de stock por producto y/o número de lote y fecha de caducidad y envases primarios y secundarios
	Gestionar las salidas de los almacenes a las salas de distribución, y de las salas de distribución a los puntos de consumo con la posibilidad de especificar la cantidad solicitada y la concedida.
	Gestionar los lotes y las fechas de caducidad de los productos: asignación de una ubicación diferente para cada lote y/o fecha de caducidad diferente
	Permitir la programación de la reposición de existencias por producto y por depósito, teniendo en cuenta los umbrales de alerta (stock mínimo, stock crítico, stock de seguridad, etc.) y las fechas de caducidad
	Gestionar los riesgos de ruptura a nivel central según el procedimiento de gestión de las rupturas
	Estadísticas y Listados: Proporcionar datos de consumos y compras por familia, por grupo de artículos, por departamento, por año y detallado por mes. También es posible realizar la comparativa entre dos años para comprobar la evolución y definir el tipo de gráfico que queremos obtener. Facilita el seguimiento y análisis detallado de compras-consumos para la toma de decisiones relevantes.
	Disponibilidad de información sobre stocks actuales, stocks máximos, stocks mínimos, último pedido realizado, precio medio, último proveedor, punto de reorden, entre otros.
	Consultar las existencias de un artículo determinado y sus movimientos en los distintos lugares de almacenamiento: seguir las existencias de un artículo determinado, por su código de producto y por su número de lote.
	Permitir una valoración de las existencias con diferentes métodos: precios unitarios (sin IVA, con IVA), precio de coste, precio medio ponderado, cantidades
	Permitir la presentación de informes sobre la gestión de las existencias
	Permitir la edición del estado de las existencias muertas, existencias nulas, negativas, inferiores al stock mínimo, productos en pedido, ...
	Facilitar el seguimiento y análisis detallado de compras-consumos para la toma de decisiones relevantes.
11.0	Gestión de Depósitos / Almacenes
	Almacenes: Equipar al personal del depósito con una herramienta potente como para controlar múltiples áreas de operaciones del depósito en menos tiempo y con la menor cantidad de recursos posibles, proporcionando una precisión innegable en los niveles de inventario.
	Establecer áreas de almacenamiento y distribución por Almacén, Cuenta, Familias, Clases y/o Categorías de productos. Debe ser aplicable la clasificación ABC (ley de Pareto) de las existencias.
	Gestionar las localizaciones y los lugares de almacenamiento mediante la atribución de los códigos "dirección-posición" según los siguientes métodos de asignación: *Código Estático: asignación a una ubicación regular *Código Dinámico: Asignación a una ubicación libre
	Gestionar el Inventario: *Preparación del Inventario *Edición de tarjetas de Inventario *Entrada de declaraciones *Identificación de las diferencias y ajuste de las existencias *Valoración de las existencias
	Gestionar varios tipos de inventario: inventario rotativo, inventario permanente e inventario anual, semestral, trimestral, mensual, ...
	Permitir el etiquetado de productos en formato EAN-13.
	Gestionar control de lotes y caducidad de productos en almacén.
	Control de acceso de usuarios a diferentes almacenes, tipos de pedidos y grupos de artículos.
	Facilitar el seguimiento y análisis del inventario, permitiendo bloquear el inventario mientras se realiza.

	Posibilidad de integración con diferentes sistemas automatizados para almacenamiento externo como Carroussel, kardex, etc.
	Recepción de Pedidos Externos: Integración con el módulo de compras para gestionar la recepción automática de pedidos, conocer el estado de la compra en todo momento con la finalidad de poder notificar de forma inmediata a los proveedores las incidencias que se produzcan durante los pedidos, como por ejemplo, entregas tardías de mercancías, entregas parciales, entregas con caducidad no válida, devoluciones, etc.
	Entrada / Salida de Órdenes Internas: Permitir la gestión de un entorno de distribución con múltiples depósitos, el retiro de productos de estos depósitos, reabastecimiento automático, seguimiento de lotes, lectura de códigos de barras, entre otros.
	Movimientos de Stocks: Permitir realizar los siguientes procesos de movimientos de stocks: Regularización, traslados entre depósitos e inventario.
	Estadísticas y Listados: Obtener datos de consumos y compras por familia, por grupo de artículos, por departamento, para el año que el usuario desea consultar y detallados por mes. También debe ser posible realizar la comparativa entre dos años para comprobar la evolución y definir el tipo de gráfico que queremos obtener. Facilitar el seguimiento y análisis detallado de compras-consumos e inventario para la toma de decisiones relevantes.
12.0	Compras/Licitaciones
	Creación y Seguimiento de compras y licitaciones publicadas por el centro hospitalario con el fin de obtener mejores condiciones de compra
	Estimación de necesidades de compra a partir de los consumos de material de periodos anteriores
	Crear una licitación para la compra de equipamiento, asignando un presupuesto y un conjunto de partidas para su publicación
	Registro de las distintas ofertas de los proveedores para cada partida de la licitación, de forma que se pueda seleccionar la oferta más favorable.
	Registro del resultado final de la adjudicación de una determinada licitación, con la relación de artículos adjudicados a un proveedor con la cantidad y precio acordados.
	Pedidos de compra, Ordenes de compra, presupuestos, control de límites presupuestarios y cantidades de partidas asignadas a un concurso.
	GRUPO MODULOS ASISTENCIALES
1.0	Médicos
	El sistema permitirá la asociación de pacientes con los diferentes médicos que forman parte del equipo de profesionales del centro. Estos pacientes y sus procesos atencionales formarán parte de la lista de trabajo de cada médico.
	Cada médico, podrá consultar el listado de pacientes asignados a su plan de trabajo, agrupados por los diferentes tipos de episodio y acompañados de indicadores visuales que indiquen características o hechos importantes de cada uno de los pacientes, como pueden ser la situación de las pruebas diagnósticas, las alergias o antecedentes familiares, etc.
	El médico podrá seleccionar un paciente de su lista de trabajo y registrar, a partir de esta selección, diferentes citas de especialista, solicitar pruebas diagnósticas, revisar y modificar la situación actual del paciente, registrar anotaciones en el diario clínico, y asignar diagnósticos y tratamientos a dicho paciente.
	El sistema permitirá al médico asociar diagnósticos y tratamientos al episodio de un paciente siguiendo el estándar CIM10/CIE9
	El sistema deberá de disponer de una funcionalidad que permita asistir al equipo médico en el momento de registrar órdenes médicas de cuidados, tratamientos o medicación a un paciente. Este sistema de asistencia tendrá como objetivo automatizar ciertos procesos, evitando, en la medida de lo posible, la comisión de errores que pudieran resultar perjudiciales para la evolución del paciente.
	La prescripción electrónica de medicación deberá poder registrarse mediante la asignación de medicamentos por nombre comercial, por principio activo y dosis o mediante la asignación de un protocolo de medicación completo configurado previamente.
	El sistema facilitará el registro de anotaciones, así como la asociación de informes, cuestionarios y archivos de diferente naturaleza de forma cronológica en el diario clínico de evolución del paciente.
	El sistema debe de facilitar al médico la realización de informes mediante plantillas predefinidas que puedan cargar automáticamente ciertos elementos de la historia clínica del paciente y del propio episodio. Estos elementos precargados podrán ser campos identificativos del paciente, el número de episodio, el médico asignado, los diagnósticos asociados al episodio, etc. Estas plantillas de informes podrán ser diferentes en función del tipo de informe, el servicio que genera el informe, el tipo de episodio, etc.
	El módulo dispondrá de una ventana por cada paciente en la que el médico podrá consultar de forma rápida la situación actual de este paciente. La ventana deberá mostrar, entre otros, datos sobre antecedentes médicos, alergias, tratamientos y diagnósticos activos y los resultados de la última toma de constantes vitales.
	La aplicación deberá de disponer de un sistema de mensajería mediante el cual, los profesionales médicos puedan dirigir observaciones, realizar preguntas o solicitar aclaraciones a otros médicos. Este sistema de interconsultas médicas deberá hacerse cargo del flujo completo de información desde que se registra la cuestión hasta que esta ha sido aclarada y cerrada.
	El sistema deberá asociar, de manera automática, todos los datos relevantes generados por el médico durante cada episodio al expediente de historia clínica electrónica del paciente
	El sistema debe de asistir al facultativo durante el proceso de obtención de evidencias o valores que permitan la creación de escalas y el relleno de cuestionarios personalizados, de manera que la propia aplicación realice los cálculos pertinentes y produzca el resultado de manera automática en función de las características y respuestas del paciente.
	El sistema dispondrá de los siguientes cuestionarios:
	Aldrete - Escala de recuperación tras el tratamiento C271:C309
	Braden Bergstrom - Riesgo de desarrollar úlceras por presión
	CBS-Escala de carga del cuidador
	Duke UNC 11 - Apoyo social percibido por el paciente
	STAS - Calidad de la atención autoevaluada por el paciente y su familia
	Emina - Riesgo de desarrollar úlceras por presión
	Escala de Norton - Evaluación del riesgo de úlcera por presión
	Barthel - Grado de dependencia
	Escala de Lawton (mujeres) - Nivel de dependencia
	Escala de Lawton (hombres) - Nivel de dependencia
	Escala de Katz - Nivel de dependencia
	Escala SPMSQ-Pfeifer - Evaluación cognitiva
	TIN - Índice de estrés del cuidador/deterioro del paciente observado por el informante
	Escala de Zarit - Inventario de cargas
	MNA - Mini Evaluación Nutricional
	MMSE - Deterioro cognitivo (Examen de Estado Mental Folstein)
	GDS - Escala de Deterioro Global de Reisberg
	Riesgo social
	PET - Escala de Wells para el tromboembolismo pulmonar
	TVP - Escala de trombosis venosa profunda de Wells
	CGI - Impresión clínica global
	Escala de Ramsay - Escala de sedación
	Wong Baker - Escala de dolor (pediátrico)
	CURB-65 - Predicción de la mortalidad en pacientes con neumonía
	FINE/PSI - Predicción de la mortalidad en pacientes con neumonía
	ESR - Escala de somnolencia de Epworth
	CAT - Impacto de la EPOC en el bienestar del paciente
	Apgar - Estado de salud neonatal
	Tinetti - Evaluación de la marcha y el equilibrio
	GCS - Nivel de conciencia
	Escala pediátrica de Glasgow - Nivel de conciencia
	NIHSS - Escala de gravedad del ictus
	NSI - Riesgo nutricional
	Ballard - Maduración neonatal
	CHADS2-Prevención de accidentes cerebrovasculares en pacientes con fibrilación auricular
	CHAD2S2-VASc-Prevención de accidentes cerebrovasculares en pacientes con fibrilación auricular
	Apache II - Predictores de gravedad en la pancreatitis aguda

	MEWS - Sistema de Alerta Temprana Modificado
	VAS - Escala de Independencia de Cuidados Personales
	COVID19 - Cuestionario de Informe de Caso COVID18
	El sistema permitirá la gestión de Interconsultas hospitalarias, tanto la solicitud como las respuestas a la misma.
	El sistema permitirá la Interconexión/Integración con el modulo de enfermería, para consultar directamente las principales actividades de enfermería como por ejemplo: confirmación de medicación, indicaciones del médico, valoración inicial, entre otras.
	Creación de mapas dentales pediátricos y adultos para el seguimiento y la evolución dental del paciente a lo largo del tiempo. Permitir insertar marcas de problemas y operaciones en la tabla dental. Exportar el informe en pdf.
2.0	Enfermería
	<u>Worklist:</u> Lista donde visualizar los pacientes asociados al área de enfermería, agrupados por tipo de episodio (hospitalizados, consulta, urgencias)
	<u>Diario clínico:</u> Espacio donde el profesional de enfermería realiza las anotaciones pertinentes sobre el cuidado, permitiendo realizar consultas y facilitando así el trabajo de enfermería.
	Trabajar con modelos de evolución predefinidos, lo que enriquece el registro de información y ayuda en el seguimiento de evoluciones previas. Aplicar modelos genéricos por tipo de episodio y modelos genéricos por departamento.
	<u>Evaluación inicial:</u> Realización de la evaluación inicial del Paciente. Esta evaluación permite la previsión de actividades para ayudar a los gerentes a tomar decisiones sobre la asignación de personal a cada unidad.
	<u>Toma de Constantes:</u> Control y obtención de datos clínicos, registrar en el expediente médico del paciente.
	<u>Planificación de la atención:</u> Administración y definición de planes de atención de cuidados de enfermería estandarizados y coordinación de los procedimientos de tratamiento.
	<u>Kardex:</u> Pantalla de consulta de todas las dispensaciones de medicación y cuidados que se deben aplicar al paciente bajo prescripción médica, con su correspondiente registro de fecha y hora para la dispensación.
	Gestión y control del trabajo realizado por las unidades de enfermería.
	<u>Informes y Listados:</u> Facilitar el control y obtención de datos clínicos para poder utilizarlos, tanto a nivel de control de la unidad como a nivel de gestión de enfermería hospitalaria.
3.0	Quirófanos
	<u>Configuración de quirófanos:</u> Permitir al usuario definir los quirófanos existentes, realizar su asignación por departamento, por procedimiento quirúrgico o por médico, por día y por horario. Indicar períodos de inactividad y el motivo correspondiente.
	<u>Gestión de programación:</u>
	Permitir la programación del quirófano para un período determinado y para un departamento o médico determinado. Control de disponibilidad de salas para programación de actividades, combinando los materiales necesarios y el control de los recursos disponibles.
	Gestionar y registrar una planificación completa de los procedimientos técnicos necesarios para el proceso de gestión del quirófano.
	Vincular un procedimiento a un kit quirúrgico predefinido o a un conjunto de equipos.
	Gestionar el depósito de kits y asociarlos a cada intervención, debiendo quedar registrado todo el material necesario para la realización de la operación: *Dispositivos médicos *Medicamentos *Instrumentación
	Proceso de bloqueo de programación de un paciente si no se han cumplido los procedimientos previos
	<u>Gestión de ejecución:</u>
	Permitir el registro de toda la actividad realizada durante la ejecución, tanto clínica como de los recursos y materiales utilizados durante la intervención además de los previamente programados, para poder utilizarlo posteriormente en informes, facturas, etc.
	Gestionar y registrar la actividad desde su programación, durante su ejecución y post-operatorio, permitiendo el registro y el control de las actividades quirúrgicas tanto programadas como en emergencia.
	Seguimiento y registro de todo el personal sanitario que participa en la intervención, como cirujanos, anestesiólogos, enfermería, etc.
	Incluir en el expediente médico toda la actividad e informes elaborados en quirófano.
	Gestionar los traslados inter e intra servicios (traslado al servicio, a la unidad de cuidados intensivos, reanimación..)
	<u>Gestionar las intervenciones urgentes:</u> *Registro de criterios necesarios para calificar la solicitud de intervención *Planificación de intervención no incluida en el programa de servicios
	<u>Reanimación:</u> Permitir gestionar los cuidados en la reanimación: *Solicitud de procedimientos adicionales (biología y radiología) y acceso a los resultados en tiempo real *Prescripción de productos sanitarios *Plan de cuidados
	Visualizar en pantalla las programaciones de quirófano por día o por semana para conocer la actividad planificada.
	<u>Estadísticas y Listados:</u> Obtener los datos de las ejecuciones programadas, las ejecuciones ejecutadas y las ejecuciones canceladas por médico, por departamento. Calcular las estadísticas e indicadores de actividad y calidad que facilitan el seguimiento y análisis detallado para poder tomar decisiones relevantes y facilitar la optimización de recursos y mejor atención al paciente.
	Los datos recopilados en este módulo se utilizarán para obtener posteriormente estadísticas e indicadores de calidad para el Tablero.
4.0	Obstetricia
	Seguimiento del embarazo desde la primera consulta del inicio del embarazo hasta su finalización con el parto y posterior creación del expediente médico del recién nacido. El sistema debe tener un sistema de perfiles de usuario para cada tipo de intervención profesional durante todo el episodio. Los administradores deben generar los perfiles y ofrecer una característica u otra según el perfil elegido. Los perfiles predeterminados que deben ser definidos son: *Ginecólogos *Parteras *Enfermeras *Anestesiólogos *Pediatras
	Control gestacional, registro de embarazos y partos previos, estado serológico, antecedentes y exámenes realizados.
	<u>Auscultación médica:</u> Registro de todas las auscultaciones realizadas a la paciente durante el período de gestación y exploración vaginal.
	<u>Anestesia:</u> Bloque funcional del anestesiólogo, antes y después del parto, permitiendo un registro completo de los fármacos dispensados a la paciente en cada momento.
	<u>Partograma gráfico siguiendo las normas de la OMS:</u> Bloque funcional para la obtención del Partograma durante su ejecución. Tiene que permitir registrar y visualizarse gráficamente según los parámetros de la OMS: *Registro de frecuencia fetal de cada feto *Líquido amniótico - Moldeamientos *Dilatación cuello uterino - Descenso cefálico *Nº de Contracciones por tiempo *Registro de Oxitocina UL Gotas/Minuto *Medicamentos administrados y Líquidos IV *Pulso - Presión Arterial representada en una única gráfica *Temperatura *Proteína Acetona Volumen
	Otras funcionalidades esenciales que deben poder ser registradas en este módulo son las siguientes:
	* Terapia de fluidos y medicamentos
	* Antes del parto
	* Condiciones de salida

	* Toque vaginal
	* Control del bienestar fetal
	* Resumen de la reseña
	* Personal involucrado en el parto
	* Parto, registro del resultado del parto, personal encargado de llevarlo a cabo, etc.
	*Postparto, registro de recién nacidos y cierre de partos
	*Creación de datos de recién nacidos en el sistema, incluyendo sus propios registros médicos.
5.0	Crecimiento y desarrollo
	El módulo CRED permite gestionar los datos de las primeras visitas del bebé al pediatra así como su evolución. El profesional monitorea al niño según el crecimiento que se traduce en un aumento de peso y talla y por el desarrollo que se define como cambios en las estructuras físicas y neurológicas, cognitivas y conductuales, que el sistema evalúa en base a los datos ingresados, produciendo gráficos y resultados estándar; identificando si es el caso, situaciones de riesgo o alteraciones en el crecimiento y desarrollo para una gestión eficaz.
	Registrar, durante cada visita de seguimiento del niño, los datos relacionados con el peso, la altura, la circunferencia de la cabeza, etc.
	Registrar, durante cada visita de seguimiento del niño, los datos del diagnóstico nutricional de Peso / Edad, Altura / Edad, Peso / Altura e IMC / Edad
	Consultar, a partir de los datos registrados, las distintas gráficas de crecimiento de Peso, Talla e IMC de las curvas SCORES y OMS
	Registrar un cuestionario de evaluación psicomotora según su edad en el momento de cada visita de seguimiento:
	*Recién nacido
	*Menor de 1 año
	*1er año
	*2do año
	*3er año
	*4to año
	*De 5 a 10 años
	*De 10 a 20 años
	Enlazar datos del parto y nacimiento provenientes del Modulo de Obstetricia
6.0	Vacunas
	Configuración de "Calendario Vacunal Standard" especificando tipo de vacuna, dosis necesaria, edad de administración e intervalos entre dosis.
	Consultar y Registrar la administración de vacunas a través de un "Calendario Vacunal Standard" donde se visualice las vacunas administradas y las pendientes de administrar con su correspondiente fecha de administración por vacuna.
	Capacidad de registrar vacunas fuera del calendario vacunal standard por necesidades puntuales.
	Estado Inmune Vacuna: registro de dosis por vacuna, edad teórica de vacunación frente a edad real de vacunación, cumplimiento de inmunidad una vez administradas las dosis necesarias en tiempo estipulado por vacuna.
7.0	Dietético
	Gestión de planes: Crear planes indicando el tipo de plan, configuración de menús, asignación a pacientes y acompañantes. La planificación del menú facilita las decisiones relevantes y facilita la relación calidad-precio.
	Control de comidas:
	Realizar un control integral de las comidas del paciente, teniendo en cuenta la prescripción del médico y las notas de enfermería. Registrar en el expediente medico del paciente la dieta aplicada y el control de comidas detallado. Administrativamente la configuración de menús facilita el control de pedidos de los artículos necesarios para la elaboración de la misma.
	Permite identificar dietas, suplementos y volúmenes normales, entéricos (biberones), identificando los componentes y el número de ingestas.
	Permite asignar menús suplementarios a pacientes no hospitalizados.
	Organización de áreas de distribución, según criterio (enfermería, cocina)
	Planificar la gestión de dietas por edificio, planta, departamento.
	Estadísticas y Listados: Permite obtener datos de regímenes y menús asignados a los pacientes así como el cálculo de estadísticas e indicadores de actividad y calidad que facilitan el seguimiento y análisis.
8.0	RIS
	Informes:
	*Gestión completa de informes, disponibilidad de una hoja de trabajo para controlar el estado de los informes.
	*Permitir la parametrización y configuración de modelos predefinidos que serán utilizados como base para la elaboración de informes.
	*Capacidad de preconfigurar modelos que serán solicitados automáticamente por el sistema al confirmar la ejecución del examen o exámenes.
	*Como control de seguridad debe incluir el concepto marca de firma. Este control significa que mientras el informe no esté firmado, solo podrá ser consultado y modificado por su autor; una vez firmado y publicado nadie (ni siquiera el autor) puede modificarlo, solo será posible realizar un informe adicional. *Una vez que el informe esté firmado y publicado, pasará a formar parte de la historia clínica electrónica.
	Disponibilidad de opciones para la creación de informes. Con el editor integrado, es posible crear inserciones automáticas para poder utilizarlas a la hora de redactar informes.
	Disponibilidad de Informe de examen utilizando plantillas predefinidas por tipo de examen.
	Asociación de varios tipos de modelos con una agenda determinada.
	Firma de informes
	Acceso a Informes por los Servicios correspondientes.
9.0	Farmacia
	El sistema debe suministrar una solución completa para la gestión de los diferentes medicamentos y productos fungibles, teniendo en cuenta en todo momento su stock en los diferentes almacenes.
	Debe de existir la posibilidad de identificar los medicamentos en el sistema a partir de la lectura del código de barras de los mismos.
	La gestión de los medicamentos se debe realizar teniendo en cuenta los diferentes lotes de fabricación y la fecha de caducidad de cada lote.
	La aplicación permitirá registrar la lista de principios activos y la relación entre un medicamento y los principios activos que lo componen.
	El sistema permitirá la generación de una propuesta de concurso de compra que incluya la lista de artículos solicitados en dicho concurso.
	El sistema permitirá la realización de pedidos a proveedor con la lista de artículos demandados, indicando, para cada pedido, si está relacionado con la adjudicación previa de un concurso o no. En el caso de que el pedido a proveedor esté relacionado con la adjudicación de un concurso, la aplicación deberá controlar que los artículos incluidos en el pedido se corresponden con los artículos adjudicados en el concurso y que no se superan las cantidades acordadas.
	La aplicación permitirá el registro de entregas de material por parte del proveedor haciendo que aumente el stock en el almacén correspondiente.
	La aplicación permitirá dirigir pedidos de reposición de material desde los servicios a los almacenes. El personal del almacén, durante la operación de reposición, validará las cantidades de material entregadas al servicio haciendo que la aplicación actualice automáticamente el stock del almacén que sirve el material.
	El sistema deberá informar al usuario de qué lotes de medicamentos están próximos a caducar.
	El sistema deberá permitir agrupar varios artículos para formar kits.
	El sistema deberá asistir al usuario en las operaciones de realización de pedidos, proponiendo automáticamente artículos y cantidades en función del stock actual y unos niveles de stock mínimos fijados para cada artículo y servicio.
	El módulo permitirá conocer el stock por almacén en todo momento, así como la realización de inventarios y correcciones puntuales en los niveles de stock
	Dispensación - Análisis de las dispensaciones según la prescripción:
	Edición del historial de prescripciones de un periodo determinado. Acceso al expediente del paciente. Confirmación y validación de órdenes médicas para pacientes hospitalizados, urgencias o ambulatorios, permite configurar medicamentos con las dosis o protocolos de medicamentos más habituales. Facilita el seguimiento y análisis del perfil farmacoterapéutico de un paciente.

	Consultar recetas según varios tipos de prescripción: *Recetas de medicamentos *Prescripciones de nutrición parenteral *Prescripciones basadas en protocolos con la posibilidad de prescribir el protocolo tal cual o modificarlo. *Prescripción de estupefacientes y fármacos caros: prever la integración de la validación *Limitación de la prescripción de determinados medicamentos en función del tipo de Episodio o Servicio
	Alertar en caso de doble prescripción o cambio de protocolo y pedir una autorización
	Área de comentarios libres para el médico, el farmacéutico y la enfermera con acceso abierto o limitado al perfil autorizado
	Proporcionar asistencia al análisis farmacéutico para que el farmacéutico pueda: *Validar la prescripción *Proponer la sustitución de uno o varios elementos de la prescripción y notificarlo al prescriptor (integrando las disponibles) *No validar la prescripción con la posibilidad de enviar comentarios o nuevas propuestas al prescriptor
	<u>Entrega:</u>
	Gestionar las entregas nominativas: El cálculo de las unidades de producto que hay que sacar del stock del punto de dispensación por paciente, especialmente para los productos multidosis (jarabe, gotas, colirios, ...) debe ser objeto de un cálculo automático (conversión de las dosis prescritas en número de viales).
	Gestionar las asignaciones globales: Calcular las unidades de producto que hay que sacar del stock del punto de dispensación por departamento y paciente
	Gestionar las existencias del armario de la sala, para las unidades en dispensación global permitiendo una reposición de los armarios y un seguimiento de las existencias de los productos en dotación.
	Gestionar las solicitudes de renovación de los productos que componen la dotación destinada a los servicios
	<u>Administración del tratamiento:</u>
	Actualizar automáticamente el plan de administración tras la validación farmacéutica de la prescripción
	Editar la prescripción en forma de plan de administración presentado por franja horaria y dando al personal de enfermería toda la información necesaria para una administración optimizada
	Integrar la prescripción validada en el plan de cuidados de enfermería
	Editar las etiquetas de las infusiones con el tratamiento y la dosis
	<u>Preparación de citotóxicos</u>
	Programar las citas de los pacientes y supervisar los ciclos y cursos de tratamiento de los mismos
	Determinar la identidad del prescriptor, departamento, unidad, perfil...
	Determinar la identidad del farmacéutico, perfil, departamento, unidad
	Prescribir productos en dosis estandarizadas con valores mínimos y máximos
	Proporcionar los datos necesarios para la validación de una prescripción: administrativos, médicos
	Proponer las especialidades disponibles correspondientes a la DCI citada en la receta con una propuesta de cantidad (para activar el proceso de preparación)
	La aplicación deberá disponer de una serie de listados o reportes, generados en varios formatos o imprimibles en papel, con información estadística sobre:
	Existencias y los movimientos de existencias.
	Generar la fecha y hora del pedido y la entrega de la prescripción y editar un informe por servicio y por familia.
	Consultar el número de pacientes por grupo de edad y patología por servicio
	Calcular el consumo y las asignaciones por denominación y por familia de servicios en unidades de gramaje para un período
	Calcular la alerta de caducidad teniendo en cuenta la vida útil y los movimientos de los productos
	Consultar el boletín de traspaso de artículos próximos a caducar o en stock muerto
	Parametrizar la nomenclatura de los actos y sus citas (asignación de coeficientes) de acuerdo con la normativa
	Consultar el historial de movimientos del producto
	Permitir proponer asignaciones departamentales (calculadas teniendo en cuenta las existencias disponibles) que pueden ser ajustadas por el equipo farmacéutico.
	Poder controlar el consumo por artículos, por paciente y por servicios
	Consultar las estadísticas de consumo de todo el establecimiento o por departamento, por producto, por clase, por paciente.
	Permitir obtener datos de consumo por familia, por grupo terapéutico, por servicio, por principios activos, por nombres comerciales, para el año que el usuario desea consultar y detallados por mes.
	Facilitar el seguimiento y análisis detallado de compras-consumos para la toma de decisiones relevantes.
10.0	Diabetes e hipertensión arterial
	seguimiento de los pacientes hipertensos y diabéticos por el modulo de enfermería, especialistas .
11.0	Informes dinámicos departamentales
	Posibilidad de crear plantillas presonalizadas para cada servicio. Estas plantillas pueden tener listas, textos predefinidos e incluso se puede incorporar imágenes para que el personal clínico realicen anotaciones o marcas sobre las imágenes.
	La información de cada campo de las plantillas está guardada de forma individual en la BBDD, esto posibilita el futuro trabajo de estudios o implementar IA con Machine Learning.
	GRUPO MODULOS COMPLEMENTARIOS
1.0	Laboratorios - Integración
	El sistema se encargara de realizar las solicitudes de exámenes de laboratorio desde el sistema HIS hasta el sistema de laboratorio
	El sistema deberá compartir las mismas referencias para identificar los servicios y los pacientes
	Se permitirá acceso a los biólogos a una vista específica adaptada a su perfil al expediente del paciente para facilitar la gestión de los exámenes solicitados.
	El sistema de laboratorio devolverá los resultados al sistema HIS en un formato estructurado, accesible para la codificación e inserción en el expediente del paciente y la posterior facturación.
	El sistema dispondrá de un sistema de notificación para los prescriptores de las pruebas sobre la disponibilidad de las mismas una vez hayan sido recibidas.